



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
KOMITE KEPERAWATAN
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 935.13/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

**Tentang
Pedoman Kerja Komite Keperawatan**

Penanggung Jawab



(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Kerja Komite Keperawatan ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Keperawatan di rumah sakit, guna mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan yang profesional, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan terkait Komite Keperawatan, serta standar akreditasi rumah sakit yang menekankan pentingnya tata kelola klinis (clinical governance), kredensial, peningkatan kompetensi, serta evaluasi kinerja tenaga keperawatan secara berkelanjutan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Komite Keperawatan dalam melaksanakan fungsi utama, yaitu kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi. Selain itu, pedoman ini juga menjadi dasar dalam menjamin bahwa seluruh tenaga keperawatan memiliki kompetensi yang sesuai, bekerja sesuai standar profesi, serta memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan dalam meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini..

Malang, 1 November 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

TIM PENYUSUN

1. Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep
2. Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep
3. Nisfil Fitria, AMd.Kep
4. Siti Maysaroh, AMd.Kep
5. Debi Firmanasia, AMd.Kep
6. Ninis Indrawati, S.Tr.Keb
7. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.Ns
8. Aini Nur Rohmah, AMd.Kep
9. Nila Martiasani, AMd.Kep
10. Ns. Lilo Palupi, S.Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL.....i

PENGESAHANii

KATA PENGANTAR.....iii

TIM PENYUSUNiv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL.....vi

PERATURAN DIREKTURvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Dasar Hukum2

 1.3 Maksud dan Tujuan2

 1.4 Ruang Lingkup.....2

 1.5 Batasan Operasional2

BAB II STANDAR KETENAGAAN4

 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia4

 2.2 Distribusi Ketenagaan.....4

 2.3 Struktur Organisasi Komite Keperawatan5

 2.4 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang5

BAB III STANDAR FASILITAS.....9

 3.1 Denah Ruangan.....9

 3.2 Standar Fasilitas9

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN.....10

 4.1 Proses Kredensial.....10

 4.2 Diskusi Refleksi Kasus.....12

 4.3 Audit Keperawatan dan Kebidanan.....13

 4.4 Pemberian Tindakan Disiplin15

 4.5 Mekanisme Kerja16

BAB V HUBUNGAN KERJA.....18

 5.1 Prinsip Umum18

 5.2 Mekanisme Hubungan Kerja.....18

BAB VI LOGISTIK.....19

BAB VII KESELAMATAN PASIEN20

BAB VIII KESELAMTAN KERJA21

BAB IX PENGENDALIAN MUTU22

BAB X PENUTUP23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1	Standar Fasilitas Ruang Komite Keperawatan	9
Tabel 4.1.1	Prosedur Kredensial Perawat.....	10
Tabel 4.2.1	Tatalaksana Diskusi Refleksi Kasus.....	12
Tabel 4.3.1	Tatalaksana Audit Keperawatan dan Kebidanan	13
Tabel 4.4.1	Tatalaksana Pemberian Tindakan Disiplin	15



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 935.13/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

PEDOMAN KERJA KOMITE KEPERAWATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien di rumah sakit, diperlukan tata kelola klinis keperawatan yang profesional, akuntabel, dan sesuai standar;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Keperawatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan serta standar akreditasi rumah sakit, diperlukan pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Kerja Komite Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat.
6. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
7. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE KEPERAWATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Pedoman Kerja Komite Keperawatan ini, yang dimaksud dengan:
(1) Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan



- profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi;
- (2) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - (3) Kewenangan klinis tenaga keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya;
 - (4) Penugasan klinis adalah penugasan kepala/direktur Rumah Sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar Kewenangan Klinis;
 - (5) Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis;
 - (6) Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut;
 - (7) Peraturan Internal Staf Keperawatan adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di Rumah Sakit;
 - (8) Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi perawat dan bidan;
 - (9) Mitra Bestari adalah sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan;
 - (10) Buku Putih adalah dokumen yang berisi syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan Kewenangan Klinis.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2 Struktur Organisasi

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, Direktur Rumah Sakit membentuk Komite Keperawatan;
- (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan dan kebidanan;
- (3) Susunan organisasi Komite Keperawatan terdiri dari :
 - a. Ketua Komite Keperawatan;
 - b. Sekretaris Komite Keperawatan; dan
 - c. Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi;
- (4) Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi dan perilaku;



- (5) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit;
- (6) Sekretaris Keperawatan dan Subkomite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

Pasal 3

Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite Keperawatan dibantu oleh Sub komite;
- (2) Masing – masing sub komite mempunyai mekanisme dan kewenangan yang jelas untuk mendukung pelaksanaan fungsi Komite Keperawatan secara profesional dan akuntabel;
- (3) Subkomite bekerja secara koordinatif dibawah Ketua Komite Keperawatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit melalui Komite Keperawatan;
- (4) Pelaksanaan tugas Subkomite dilakukan secara independen, objektif dan terdokumentasi.

Pasal 4

Tata Hubungan Kerja

- (1) Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dan bekerja sama secara profesional dengan Direktur Rumah Sakit, unsur manajemen, Komite Medik, serta unit kerja terkait lainnya;
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif, dan fungsional, dengan tetap menjaga independensi Komite Keperawatan dalam melaksanakan fungsi kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi keperawatan;
- (3) Komite Keperawatan menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kewenangan klinis, pembinaan tenaga keperawatan, serta peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Keperawatan wajib menjalin komunikasi efektif dan berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung tercapainya pelayanan keperawatan yang bermutu dan berfokus pada keselamatan pasien.

BAB III

TATA LAKSANA

Pasal 5

Sub Komite Kredensial

- (1) Subkomite Kredensial bertanggung jawab melakukan verifikasi, evaluasi, dan penilaian kompetensi tenaga keperawatan dalam rangka pemberian, perpanjangan, pembatasan, atau pencabutan kewenangan klinis (clinical privilege);



- (2) Pelaksanaan kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme yang meliputi penilaian dokumen, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, serta hasil evaluasi kinerja dan praktik profesional;
- (3) Subkomite Kredensial menyusun rekomendasi kewenangan klinis tenaga keperawatan kepada Komite Keperawatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit sebagai dasar penetapan kewenangan klinis;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Subkomite Kredensial wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi tenaga keperawatan serta menjunjung tinggi etika profesi dan prinsip keselamatan pasien.

Pasal 6

Sub Komite Mutu Profesi

- (1) Subkomite Mutu Profesi bertugas menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan melalui evaluasi dan pembinaan profesional berkelanjutan;
- (2) Subkomite Mutu Profesi bekerja secara terstruktur dan terjadwal untuk memastikan tercapainya standar mutu pelayanan sesuai regulasi dan akreditasi;
- (3) Penjagaan mutu profesi dilaksanakan dengan pendekatan non punitif, berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Pasal 7

Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

- (1) Subkomite Etik dan Disiplin Profesi bertugas menangani permasalahan etik dan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan, serta memberikan rekomendasi pembinaan kepada pimpinan rumah sakit;
- (2) Dalam hal pelanggaran berat atau yang memerlukan kewenangan profesi lebih lanjut, subkomite dapat merekomendasikan pelimpahan kepada bagian SDM sesuai peraturan yang berlaku;
- (3) Hasil pembinaan etik dan disiplin dijadikan bahan evaluasi mutu dan perbaikan sistem kerja keperawatan di rumah sakit.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Komite Keperawatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewenangan klinis, mutu praktik keperawatan, serta kepatuhan tenaga keperawatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan etika keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi rumah sakit;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit keperawatan, telaah sejawat (*peer review*), serta penilaian kinerja tenaga keperawatan secara berkesinambungan;



- (3) Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan secara sistematis dan digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan mutu, peningkatan kompetensi, serta penetapan atau peninjauan kembali kewenangan klinis tenaga keperawatan;
- (4) Komite Keperawatan menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Rumah Sakit secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

PASAL V PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, peraturan direktur rumah sakit prima husada nomor 086.4/RSPHS/I-PER/DIR/I/2020 tentang Pedoman Kerja Komite Keperawatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 935.13/RSPHS/I-
PER/DIR/XI/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE
KEPERAWATAN**

PEDOMAN KERJA KOMITE KEPERAWATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang berperan penting dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta kewenangan klinis yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap tindakan keperawatan harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi yang terukur, kredensial yang sah, serta penetapan kewenangan klinis yang jelas dan terdokumentasi.

Dalam praktiknya, kompleksitas pelayanan kesehatan yang semakin berkembang menuntut adanya sistem tata kelola klinis yang mampu memastikan bahwa setiap perawat hanya melaksanakan tindakan sesuai dengan tingkat pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan hasil kredensial yang dimiliki. Ketidaksesuaian antara kompetensi dan kewenangan klinis berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pasien, masalah etik dan hukum, serta menurunkan mutu pelayanan rumah sakit.

Komite Keperawatan memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, rekredensial, penetapan dan evaluasi kewenangan klinis, serta pembinaan kompetensi secara berkelanjutan. Proses tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan diberikan oleh tenaga yang kompeten, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku, serta memenuhi persyaratan kompetensi sesuai regulasi dan standar akreditasi rumah sakit.

Selain itu, perkembangan regulasi kesehatan dan tuntutan standar akreditasi menekankan pentingnya tata kelola klinis yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Rumah sakit wajib memiliki sistem yang menjamin bahwa seluruh tenaga keperawatan bekerja sesuai kewenangan klinis yang telah ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan Pedoman Kerja Komite Keperawatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam proses kredensial, penetapan kewenangan klinis, pemeliharaan dan peningkatan kompetensi perawat, serta pengawasan praktik profesional keperawatan. Pedoman ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang profesional, aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien..

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Kerja Komite Keperawatan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komite Keperawatan di Rumah Sakit guna menjamin tata kelola klinis keperawatan yang profesional, bermutu, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi yang berlaku.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan sistem tata kelola klinis keperawatan yang efektif dan terstandar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, menjaga profesionalisme tenaga keperawatan, serta mendukung keselamatan pasien di Rumah Sakit.

3. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kredensial, rekredensial, dan penilaian kewenangan klinis tenaga keperawatan.
- b. Menjamin pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan.
- c. Meningkatkan kepatuhan tenaga keperawatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, SPO, serta kode etik keperawatan.
- d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin profesi keperawatan di Rumah Sakit.
- e. Mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui monitoring dan evaluasi praktik keperawatan.
- f. Mewujudkan tata kelola organisasi keperawatan yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.
- g. Menjadi dasar dalam koordinasi antara Komite Keperawatan, manajemen rumah sakit, dan unit pelayanan dalam rangka peningkatan mutu layanan.

1.3 Ruang Lingkup

1. Komite keperawatan merupakan kelompok profesi tenaga keperawatan yang secara struktural fungsional berada dibawah Direktorat Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Komite keperawatan bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan dan kebidanan di rumah sakit.
3. Komite keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
4. Komite keperawatan menjadi mitra manajemen dengan mengembangkan kerjasama sinergik antar lembaga terkait.

1.4 Batasan Operasional

1. Fungsi komite keperawatan dalam kaitan dengan bidang keperawatan
 - a. Bukan hubungan atasan bawahan, melainkan hubungan kerjasama, koordinasi, kemitraan dan saling menguatkan.
 - b. Media utama untuk mengakomodasikan dan memfasilitasi berkembangnya profesionalisme keperawatan yang dapat mempertahankan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan.

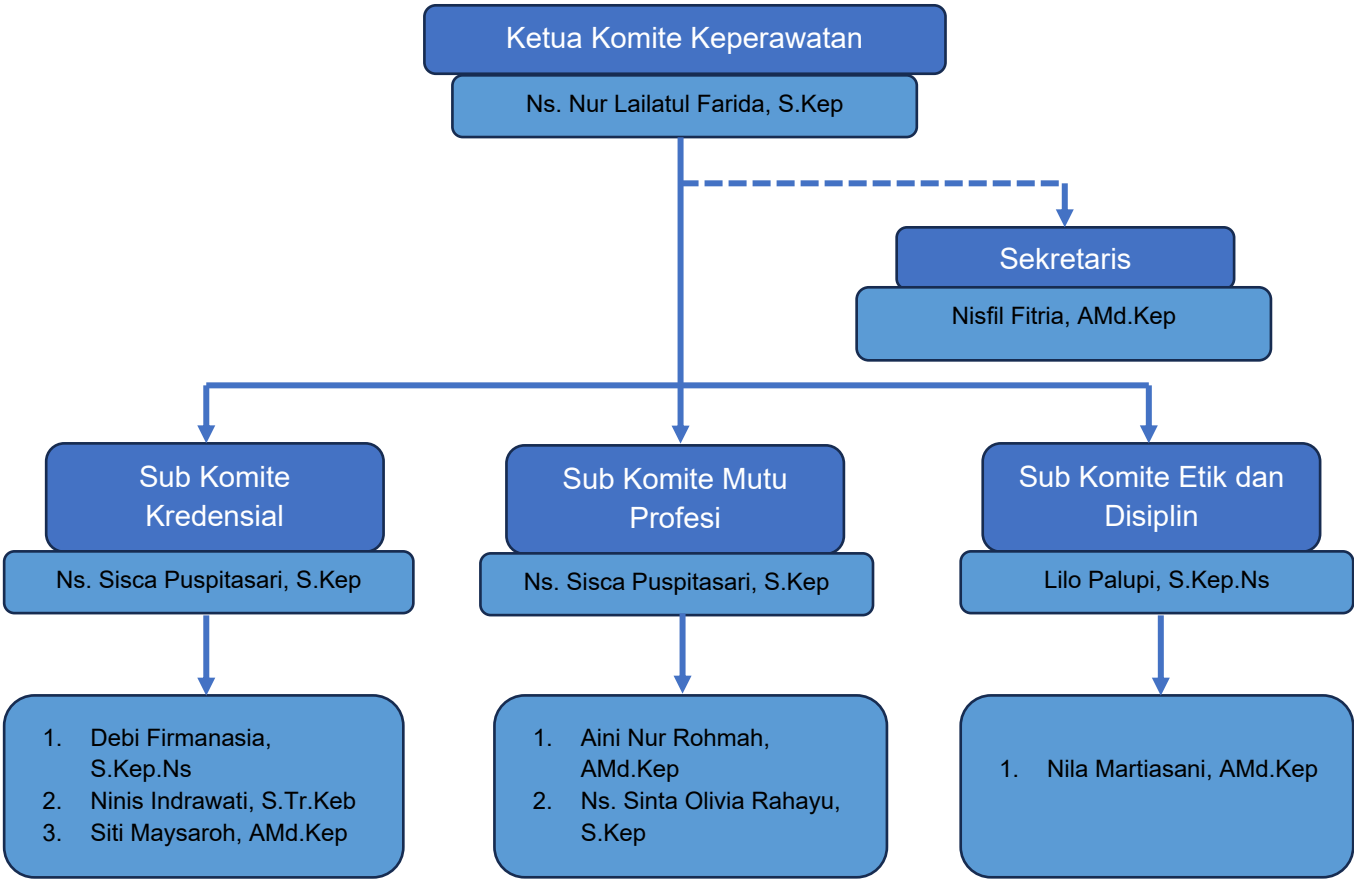
-
- c. Menjadi mitra keperawatan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan bidan keperawatan.
 - d. Membantu fungsi – fungsi manajemen dan menyelesaikan persoalan operasional.
 - e. Memberikan penasehatan terkait aspek profesi keperawatan
2. Fungsi komite keperawatan dalam kaitannya dengan pelayanan keperawatan rumah sakit
- a. Menjamin tersedianya norma – norma ; standar praktik/ asuhan/ prosedur keperawatan sesuai lingkup asuhan keperawatan dan pelayanan serta aspek penting asuhan di seluruh area keperawatan.
 - b. Menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu keperawatan tingkat rumah sakit.
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan pemantauan mutu dan evaluasi keperawatan
 - d. Mengintegrasikan proses peningkatan mutu keperawatan dengan rencana rumah sakit untuk menemukan kecenderungan dan pola kinerja yang berdampak pada lebih dari satu departemen atau pelayanan.
 - e. Mengusulkan solusi pada manajemen atas masalah yang berkaitan dengan keprofesionalan tenaga dan asuhan dalam sistem pemberian asuhan.
3. Fungsi komite keperawatan dalam kaitan dengan anggota komite
- a. Menetapkan lingkup praktek, kompetensi dan kewenangan fungsional tenaga keperawatan
 - b. Merumuskan norma – norma, harapan dan pedoman perilaku
 - c. Menyediakan alat ukur kinerja keperawatan
 - d. Memelihara dan meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kinerja anggota.

BAB II

PENGORGANISASIAN

2.1 Struktur Organisasi Komite Keperawatan

- 1. Komite keperawatan terdiri dari orang – orang yang mempunyai komitmen, energi, dan waktu yang cukup, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan.
- 2. Anggota mewakili setiap bidang keahlian pelayanan
- 3. Jumlah anggota cukup untuk menyelesaikan tugas – tugas komite.



Bagan 2.1.1 Struktur Organisasi Komite Keperawatan

2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- 1. Ketua Komite Keperawatan
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Merencanakan program dan anggaran komite keperawatan, pembinaan, penilaian, pengembangan baik tata laksana kerja tugas – tugas dan karyawan, peningkatan kinerja dan mutu pelayanan keperawatan.
 - 2) Memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit terkait upaya – upaya peningkatan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit.
 - 3) Menetapkan pembagian tugas, batas-batas tugas, tanggung jawab, kewenangan hubungan kerja yang jelas bagi karyawan sesuai dengan bidang pekerjaan masing- masing.
 - 4) Mengkoordinasi pengurus Komite Keperawatan yang terdiri dari Sub Kredensial, Sub Mutu Profesi dan Sub Etik dan Disiplin Profesi.

- 5) Memberi pengarahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan guna tercapai tujuan pelayanan secara efektif dan efisien dalam suasana kerja yang kondusif.
- 6) Melakukan pengawasan/pengontrolan mencakup tugas: meneliti, menganalisis pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan, menilai hasil pekerjaan dan mengoreksi, merevisi pekerjaan guna tercapai tujuan akhir pelayanan (kepuasan pelanggan) sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan unit atau penanggung jawab program lain dan manajemen
- 8) Menyusun Pedoman Kerja Komite Keperawatan
- 9) Merencanakan atau melaksanakan pelatihan dalam lingkup keperawatan dan kebidanan.
- 10) Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan
- 11) Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada kepala /direktur Rumah Sakit.

b. Tanggung Jawab

- 1) Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan atau target pelayanan yang ingin dicapai Rumah Sakit.
- 2) Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
- 3) Mensupervisi dan mengkoordinasi bagian-bagian pelayanan.
- 4) Melakukan pengawasan dan pengontrolan bidang pelayanan keperawatan.

c. Wewenang

- 1) Pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan
- 2) Penyusunan rencana kerja tahunan
- 3) Pengarahan dan pengaturan tugas
- 4) Memimpin rapat
- 5) Merekomendasikan kewenangan staf klinis keperawatan berdasarkan hasil proses kredensial.
- 6) Merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesionalisme berkelanjutan berdasarkan asesmen kompetensi.

2. Sekretaris Komite Keperawatan

a. Uraian Tugas

- 1) Menyusun jadwal kegiatan Komite Keperawatan setiap awal periode kepengurusan bersama dengan Ketua Komite Keperawatan.
- 2) Mengelola dokumentasi Komite Keperawatan termasuk arsip, ekspedisi surat masuk dan surat keluar.
- 3) Mengatur penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Komite Keperawatan agar proses kegiatan berjalan dengan lancar.
- 4) Mencatat, menyimpan & melaporkan setiap kegiatan komite keperawatan
- 5) Mengelola kantor komite keperawatan.

b. Tanggung Jawab

- 1) Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
- 2) Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas

-
- 3) Membantu ketua komite keperawatan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan Komite Keperawatan.
 - c. Wewenang
 - 1) Memberikan usulan kepada komite keperawatan.
 - 2) Melaporkan seluruh hasil kegiatan
3. Sub Komite Kredensial
- a. Uraian Tugas
 - 1) Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis.
 - 2) Menyusun buku putih (*white paper*) yang merupakan dokumen persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar kompetensinya.
 - 3) Menerima hasil verifikasi persyaratan Kredensial dari bagian SDM
 - 4) Merekomendasikan tahapan proses kredensial.
 - 5) Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga keperawatan.
 - 6) Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.
 - 7) Sub komite membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
 - 2) Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
 - c. Wewenang
 - 1) Memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis untuk memperoleh surat Penugasan Klinis (*clinical appointment*).
4. Sub Komite Mutu Profesi
- a. Uraian Tugas
 - 1) Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik.
 - 2) Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan.
 - 3) Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
 - 4) Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit.
 - 2) Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
 - c. Wewenang
 - 1) Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan, pendidikan keperawatan dan kebidanan berkelanjutan serta pendampingan
5. Sub Komite Etik dan Disiplin
- a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan.

- 2) Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.
 - 3) Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan.
 - 4) Merekomendasikan penyelesaian masalah – masalah pelanggaran disiplin dan masalah – masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
 - 5) Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau surat penugasan klinis (clinical appointment)
 - 6) Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- b. Tanggung Jawab
- 1) Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
 - 2) Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
- c. Wewenang
- 1) Memberikan usul rekomendasi pencabutan kewenangan klinis tertentu.
 - 2) Memberikan rekomendasi perubahan/ modifikasi rincian kewenangan klinis.
 - 3) Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

2.3 Tata Hubungan Kerja

1. Prinsip Umum

Hubungan kerja antara Komite Keperawatan dan Direktur Rumah Sakit bersifat koordinatif, fungsional, dan konsultatif, dengan tujuan mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan, menjaga profesionalisme tenaga keperawatan, serta melindungi keselamatan pasien, tenaga keperawatan dan rumah sakit.

Komite Keperawatan bersifat non-struktural dan tidak memiliki fungsi operasional pelayanan, namun memberikan pertimbangan profesional dan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit terkait praktik keperawatan

2. Mekanisme Hubungan Kerja

a. Jalur Koordinasi

- 1) Komite Keperawatan melakukan koordinasi langsung dengan Direktur Rumah Sakit dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan terkait kredensial, mutu profesi, serta etik dan disiplin keperawatan.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan, Komite Keperawatan dapat berkoordinasi dengan unit pelayanan, kepala instalasi keperawatan, serta bagian SDM rumah sakit sesuai kebutuhan.
- 3) Setiap kegiatan, rekomendasi atau temuan Komite Keperawatan dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit.

b. Jalur Pelaporan

1) Laporan rutin

Komite keperawatan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala (triwulan dan tahunan) kepada Direktur Rumah Sakit, yang meliputi:

- a) Kegiatan kredensial dan rekredensial
- b) Pembinaan mutu dan kompetensi
- c) Pelaksanaan audit keperawatan

-
- d) Kasus etik dan disiplin serta rekomendasi penyelesaiannya
 - 2) Laporan insidentil
Jika ditemukan pelanggaran serius atau kondisi yang dapat membahayakan keselamatan pasien atau mencederai profesionalisme keperawatan, Komite Keperawatan wajib melaporkan segera (insidentil) kepada Direktur Rumah Sakit untuk ditindaklanjuti.
 - c. Jalur Rekomendasi Profesional
 - 1) Komite keperawatan memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur Rumah sakit mengenai kewenangan klinis perawat dan bidan.
 - 2) Direktur Rumah Sakit menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam bentuk keputusan administratif dan operasional, sesuai dengan kewenangan manajerial
 - d. Rapat dan Konsultasi
 - 1) Rapat koordinasi antara Komite Keperawatan dan Direktur Rumah Sakit dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali setiap 3 bulan, atau sewaktu – waktu bila dibutuhkan.
 - 2) Dalam rapat ini dilakukan :
 - a) Penyampaian laporan kegiatan
 - b) Pembahasan masalah strategis terkait keperawatan
 - c) Pemberian arahan dan kebijakan oleh Direktur Rumah Sakit.
 - d) Penetapan rencana tindak lanjut

BAB III

TATALAKSANA

3.1 Sub Komite Kredensial

1. Kredensial

a. Tujuan Kredensial

- 1) Menjamin bahwa perawat yang memberikan pelayanan telah memenuhi standar kompetensi dan memiliki kewenangan klinis yang sah.
- 2) Menjaga mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.
- 3) Menjadi dasar bagi Direktur Rumah Sakit dalam menetapkan kewenangan klinis perawat.

b. Ruang Lingkup

Proses kredensial berlaku untuk:

- 1) Perawat baru yang akan mulai bekerja di rumah sakit.
- 2) Perawat lama yang melakukan perpanjangan kewenangan klinis (minimal setiap 3 tahun).
- 3) Perawat yang mengalami perubahan kewenangan klinis (penambahan, pembatasan, atau pencabutan).

c. Pihak yang Terlibat

- 1) Perawat yang mengajukan kredensial
- 2) Atasan langsung/ unit kerja (untuk memberikan penilaian kinerja dan rekomendasi)
- 3) Sub Komite Kredensial Komite Keperawatan.
- 4) Ketua Komite Keperawatan.
- 5) Direktur Rumah Sakit (penerbit keputusan kewenangan klinis).

d. Prosedur Kredensial Perawat

Tabel 3.1.1 Prosedur Kredensial Perawat

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pengajuan	Perawat mengajukan permohonan kredensial/ perpanjangan kewenangan dengan mengisi formulir dan melampirkan berkas persyaratan	Perawat	Formulir permohonan, ijazah, STR, SIP, sertifikasi kompetensi/ pelatihan, logbook
2	Verifikasi Administrasi	Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan legalitas berkas	Sekretaris Komite Keperawatan	Daftar cek verifikasi
3	Penilaian Kredensial	Sub Komite Kredensial melakukan penilaian terhadap: • Kualifikasi pendidikan • STR dan SIP • Kompetensi & pengalaman kerja • Rekam jejak etik dan disiplin • Evaluasi kinerja sebelumnya (jika perpanjangan)	Subkomite Kredensial	Form penilaian kredensial

4	Wawancara dan Uji Kompetensi	Melakukan kompetensi, klarifikasi atau uji keterampilan untuk memastikan kompetensi klinis	Subkomite Kredensial	Berita acara
5	Rapat Kredensial	Hasil penilaian dibahas dalam rapat subkomite kredensial dan komite keperawatan untuk menetapkan rekomendasi	Komite Keperawatan	Notulen dan berita acara rapat
6	Pemberian Rekomendasi	Komite keperawatan memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur tentang jenis kewenangan klinis yang layak diberikan	Ketua Komite Keperawatan	Surat Rekomendasi
7	Penetapan Kewenangan Klinis	Direktur rumah sakit menerbitkan Surat Penetapan Kewenangan Klinis berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan	Direktur RS	SK Kewenangan Klinis
8	Distribusi dan Sosialisasi	SK kewenangan klinis disampaikan ke unit kerja, bidang keperawatan, dan perawat yang bersangkutan	Bidang keperawatan	Daftar distribusi
9	Penyimpanan Dokumen	Seluruh dokumen kredensial disimpan rapi dalam arsip Komite Keperawatan dan rekam kepegawaian	Sekretaris Komite	Arsip fisik dan elektronik

e. Persyaratan Dokumen Kredensial

Perawat wajib melampirkan:

- 1) Fotocopy Ijazah terakhir
- 2) STR (Surat Tanda Registrasi) aktif
- 3) SIP (Surat Izin Praktik) aktif
- 4) Sertifikat pelatihan kompetensi sesuai bidang
- 5) Daftar riwayat pekerjaan dan pengalaman kerja
- 6) Logbook kegiatan klinis
- 7) Penilaian kinerja terakhir (untuk perpanjangan)

f. Perpanjangan, perubahan dan pencabutan kewenangan klinis

- 1) Perpanjangan dilakukan setiap 3 tahun dengan proses kredensial ulang
- 2) Perubahan kewenangan dapat dilakukan bila perawat telah mengikuti pelatihan atau pindah bidang praktik
- 3) Pencabutan/ pembatasan dilakukan bila :
 - a) STR/SIP tidak berlaku
 - b) Perawat melakukan pelanggaran etik/ disiplin berat
 - c) Perawat tidak memenuhi kompetensi atau kinerja tidak sesuai standar.

2. Penilaian Kompetensi

a. Penetapan Standar Kompetensi

Subkomite Kredensial menetapkan standar kompetensi yang mengacu pada standar profesi keperawatan, kewenangan klinis, uraian jabatan, serta kebutuhan pelayanan di rumah sakit. Standar ini menjadi dasar dalam proses penilaian.

- b. Pengumpulan Data dan Dokumen
Dilakukan pengumpulan dokumen tenaga keperawatan yang meliputi:
 - 1) Ijazah pendidikan terakhir
 - 2) STR (Surat Tanda Registrasi)
 - 3) Sertifikat pelatihan dan kompetensi
 - 4) Riwayat pengalaman kerja
 - 5) Logbook tindakan/kompetensi klinis
- c. Verifikasi dan Validasi Dokumen
Subkomite melakukan verifikasi keabsahan dan kesesuaian dokumen dengan standar yang ditetapkan, termasuk masa berlaku STR dan relevansi pelatihan terhadap praktik klinis.
- d. Penilaian Kompetensi Teknis (Hard Skills)
Dilakukan untuk menilai kemampuan klinis tenaga keperawatan melalui:
 - 1) Telaah logbook tindakan
 - 2) Observasi praktik klinis (bila diperlukan)
 - 3) Uji kompetensi atau demonstrasi keterampilan
- e. Penilaian Kompetensi Non Teknis (Soft Skills)
Meliputi aspek:
 - 1) Komunikasi efektif
 - 2) Etika dan profesionalisme
 - 3) Kerja sama tim
 - 4) Kepatuhan terhadap standar prosedur dan keselamatan pasien
- f. Evaluasi Kinerja
Menggunakan data penilaian kinerja berkala, indikator mutu, serta laporan insiden keselamatan pasien (jika ada) sebagai bahan pertimbangan.
- g. Analisis dan Penetapan Hasil
Subkomite Kredensial melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh hasil penilaian untuk menentukan tingkat kompetensi dan kesesuaian kewenangan klinis

3.2 Sub Komite Mutu Profesi

1. Diskusi refleksi kasus

a. Tujuan

- 1) Mengidentifikasi akar masalah dari kasus keperawatan yang terjadi.
- 2) Mendorong pembelajaran bersama secara profesional dan terbuka diantara perawat
- 3) Menyusun rencana perbaikan mutu dan keselamatan pasien
- 4) Memberikan masukan kepada manajemen dan unit pelayanan terkait peningkatan kompetensi staf keperawatan

b. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku untuk :

- 1) Semua kasus keperawatan yang signifikan, termasuk kasus dengan risiko tinggi, kejadian sentinel, KTD, KNC maupun near miss
- 2) Kasus etik dan disiplin profesi perawat yang membutuhkan penanganan bersama
- 3) Kasus klinis yang memerlukan pembelajaran reflektif lintas unit atau profesi.

c. Prosedur pelaksanaan diskusi refleksi kasus

1) Inisiasi

- a) Kasus dilaporkan melalui mekanisme pelaporan insiden atau laporan unit
- b) Sub komite mutu profesi melakukan skrinning kelayakan untuk refleksi

2) Persipan diskusi

- a) Komite menyusun undangan, agenda dan menunjuk moderator
- b) Perawat pelaksana/ unit diminta menyiapkan paparan kasus secara kronologis

3) Pelaksanaan diskusi

- a) Moderator membuka diskusi, menjelaskan tujuan dan aturan
- b) Pemaparan kasus dilakukan secara objektif, tanpa menyalahkan individu
- c) Dilanjutkan dengan analisis akar masalah
- d) Diskusi diarahkan untuk menghasilkan pembelajaran dan solusi

4) Perumusan hasil

- a) Tim komite menyimpulkan poin pembelajaran utama
- b) Menetapkan rencana perbaikan sistem, kompetensi, atau SOP
- c) Menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tindak lanjut

5) Pelaporan dan evaluasi

- a) Hasil diskusi disampaikan ke Direktur, bidang keperawatan dan unit terkait.
- b) Monitoring pelaksanaan tindak lanjut dilakukan maksimal dalam 1 bulan pasca diskusi
- c) Evaluasi efektifitas tindak lanjut dilakukan oleh Komite Keperawatan

d. Tata laksana diskusi refleksi kasus

Tabel 3.2.1 Tata Laksana Diskusi Refleksi Kasus

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Identifikasi kasus	Kasus keperawatan yang signifikan dilaporkan oleh unit atau tim mutu ke Komite Keperawatan	Kepala ruangan/ Tim Mutu	Form laporan kasus
2	Seleksi kasus	Komite keperawatan menilai kelayakan kasus untuk didiskusikan	Subkomite mutu profesi	Daftar seleksi kasus
3	Perencanaan diskusi	Menentukan jadwal, tempat, peserta dan moderator diskusi	Sekretaris komite	Undangan dan agenda
4	Pengumpulan data kasus	Mengumpulkan kronologi, dokumen asuhan, hasil audit, dan data pendukung lainnya	Tim komite/ unit terkait	Berkas kasus
5	Pelaksanaan diskusi refleksi	- Pembukaan oleh moderator - Pemaparan kasus oleh perawat pelaksana/ unit	Komite keperawatan	Notulen dan daftar hadir

		Analisis perbaikan dan pembelajaran		
6	Perumusan rekomendasi	Menyusun kesimpulan, pembelajaran dan rekomendasi perbaikan sistem atau kompetensi	Komite & Peserta	Form rekomendasi
7	Pelaporan hasil diskusi	Menyampaikan hasil diskusi refleksi kepada Direkur, bidang keperawatan dan unit terkait untuk tindak lanjut	Ketua Komite	Laporan hasil refleksi
8	Tindak lanjut & Monitoring	Rekomendasi ditindaklanjuti oleh unit dan bidang terkait, serta dimonitor oleh Komite Keperawatan	Bidang keperawatan & Komite	Form tindak lanjut

2. Audit Keperawatan dan Kebidanan

a. Tujuan

- 1) Menilai kesesuaian pelaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan dengan standar yang berlaku.
- 2) Mengidentifikasi kesenjangan mutu pelayanan serta faktor penyebabnya
- 3) Menjadi dasar perencanaan perbaikan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga keperawatan dan kebidanan
- 4) Memberikan umpan balik kepada unit pelayanan dan manajemen rumah sakit.

b. Ruang lingkup

- 1) Berlaku untuk seluruh unit pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit.
- 2) Audit dapat mencakup aspek:
 - a) Struktur (sarana, prasarana, SDM, kualifikasi)
 - b) Proses (pelaksanaan asuhan sesuai SPO dan standar praktik)
 - c) Outcome (hasil asuhan, kepuasan pasien, pencapaian target klinik)

c. Prosedur pelaksanaan audit keperawatan dan kebidanan

- 1) Inisiasi Audit
 - a) Audit dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan, insiden klinik, atau permintaan manajemen.
- 2) Perencanaan dan Penetapan Fokus
 - a) Fokus audit ditetapkan berdasarkan prioritas risiko dan mutu (misal : dokumentasi pengkajian awal, pengelolaan nyeri, edukasi pasien, EWS, hand hygiene, dll)
- 3) Pelaksanaan Audit
 - a) Tim audit melakukan observasi ke unit pelayanan.
 - b) Dilakukan telaah rekam medis
 - c) Wawancara staf untuk klasifikasi bila diperlukan
- 4) Analisis dan pelaporan
 - a) Hasil audit dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif
 - b) Dibandingkan dengan standar/ SPO rumah sakit dan regulasi nasional
 - c) Rekomendasi perbaikan disusun
- 5) Tindak lanjut dan evaluasi
 - a) Unit terkait menyusun rencana perbaikan

d. Tata laksana audit keperawatan dan kebidanan
Tabel 3.2.2 Tata Laksana Audit Keperawatan dan Kebidanan

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Perencanaan audit	- Menyusun rencana asudit tahunan/ triwulan - Menentukan topik prioritas audit (berdasarkan risiko tinggi, volume tinggi, problem prone, indikator mutu) - Menetapkan tim audit dan instrumen (checklist, format rekam medis, wawancara, observasi)	Komite Keperawatan dan Bidang Keperawatan	Rencana Audit Tahunan
2	Persiapan	- Menyusun instrumen audit (checklist, format rekam medis, wawancara, observasi) - Menentukan jadwal dan unit sasaran	Tim audit	Instrumen audit
3	Pelaksanaan Audit	- Melakukan observasi langsung ke unit pelayanan - Wawancara staf terkait bila diperlukan	Tim audit	Form audit
4	Analisis & Penelitian	- Mengolah data hasil audit - Membandingkan dengan standar/SPO - Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan akar masalah	Tim audit	Rekap hasil audit
5	Penyusunan laporan	- Menyusun laporan hasil audit (temuan, kesimpulan, rekomendasi perbaikan) - Disampaikan kepada Bidang Keperawatan	Ketua tim audit	Laporan audit
6	Tindak lanjut & evaluasi	- Unit terkait menyusun rencana perbaikan - Komite melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut	Komite & unit pelayanan	Form tindak lanjut
7	Pelaporan ke Manajemen & Komite mutu	Laporan disampaikan secara berkala kepada Direktur & Komite Mutu RS sebagai bagian PMKP	Ketua Komite keperawatan	Laporan akhir

3.3 Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan
Pemberian Tindakan Disiplin

1. Tujuan
 - a. Menegakkan disiplin dan kode etik profesi keperawatan dan kebidanan
 - b. Melindungi keselamatan pasien, masyarakat dan staf rumah sakit.
 - c. Mendorong profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi serta standar pelayanan
 - d. Memberikan efek pembinaan dan perbaikan, bukan semata – mata hukuman.
2. Jenis pelanggaran
Pelanggaran dibedakan menjadi :
 - a. Pelanggaran ringan : ketidakpatuhan terhadap tata tertib, prosedur, atau standar pelayanan yang tidak menyebabkan risiko serius pada pasien.
 - b. Pelanggaran sedang : pelanggaran yang menimbulkan dampak terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien, namun tidak mengancam jiwa.
 - c. Pelanggaran berat : pelanggaran etik aau disiplin yang menimbulkan kerugian besar, mencederai keselamatan pasien, melanggar hukum atau mencoreng citra profesi.
3. Tatalaksana pemberian tindakan disiplin

Tabel 3.4.1 Tatalaksana Pemberian Tindakan Disiplin

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Identifikasi & pelaporan dugaan pelanggaran	Pelanggaran dilaporkan oleh atasan langsung, unit atau melalui mekanisme pelaporan insiden	Kepala ruangan/ unit/ Tim Mutu	Laporan pelanggaran
2	Verifikasi awal	Komite keperawatan melakukan klasifikasi awal untuk memastikan kebenaran laporan dan klasifikasi pelanggaran	Subkomite etik & disiplin	Form verifikasi awal
3	Pemberitahuan kepada terlapor	Tenaga keperawatan diberitahu secara resmi mengenai laporan dan akan dipanggil untuk klarifikasi	Komite keperawatan	Surat pemanggilan
4	Pemeriksaan & klarifikasi	• Komite melakukan pemeriksaan objectif terhadap fakta, saksi dan dokumen • Terlapor diberi kesempatan memberikan penjelasan	Tiim pemeriksa komite	Berita acara pemeriksaan
5	Rapat penentuan tindakan	Komite keperawatan melakukan rapat internal untuk merumuskan rekomendasi tindakan disiplin sesuai tingkat pelanggaran	Komite keperawatan	Notulen rapat
6	Rekomendasi kepada Direktur	Komite keperawatan menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tindakan	Ketua Komite	Surat rekomendasi

		kepada Direktur RS untuk ditetapkan		
7	Penetapan dan pelaksanaan tindakan	Direktur menetapkan dan melaksanakan tindakan disiplin sesuai rekomendasi dan peraturan kepegawaian	Direktur RS	SK atau surat peringatan
8	Monitoring & pembinaan	Komite dan atasan langsung melakukan pembinaan lanjutan untuk memastikan perubahan perilaku	Komite & bidang keperawatan	Form tindak lanjut

3.4 Mekanisme Kerja

1. Sub Komite Kredensial

Untuk melaksanakan tugas sub komite kredensial, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut :

- Mempersiapkan kewenangan klinis mencakup kompetensi sesuai area praktik yang ditetapkan oleh rumah sakit.
- Menyusun kewenangan klinis dengan kriteria sesuai dengan persyaratan kredensial
- Melakukan assesmen kewenangan klinis dengan berbagai metode yang disepakati.
- Memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rekomendasi memperoleh penugasan klinis dari Direktur Rumah Sakit.
- Memberikan rekomendasi kewenangan klinis untuk memperoleh penugasan klinis dari Direktur Rumah Sakit dengan cara :
 - Tenaga keperawatan mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis kepada Ketua Komite Keperawatan.
 - Ketua Komite Keperawatan menugaskan sub komite Kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok)
 - Sub komite melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode ; portofolio, asesmen kompetensi
 - Sub komite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan.
- Melakukan pembinaan dan pemulihan kewenangan klinis secara berkala.
- Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.

2. Sub Komite Mutu Profesi

Untuk melaksanakan tugas sub komite mutu profesi, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut:

- Koordinasi dengan bidang keperawatan untuk memperoleh data dasar tentang profil tenaga keperawatan di rumah sakit sesuai area praktiknya berdasarkan jenjang karir.
- Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang berasal dari data subkomite kredensial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan standar profesi.
- Merekomendasikan perencanaan CPD kepada unit yang berwenang.
- Koordinasi dengan praktisi tenaga keperawatan dalam melakukan pendampingan sesuai kebutuhan.
- Melakukan audit keperawatan dan kebidanan dengan cara:

-
- 1) Pemilihan topik yang akan dilakukan audit.
 - 2) Penetapan standar dan kriteria.
 - 3) Penetapan jumlah kasus/ sampel yang akan diaudit.
 - 4) Membandingkan standar/ kriteria dengan pelaksanaan pelayanan
 - 5) Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria
 - 6) Menerapkan perbaikan
 - 7) Rencana reaudit
- f. Menyusun laporan kegiatan subkomite untuk disampaikan kepada Ketua Komite Keperawatan.

3. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

- a. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan:
 - 1) Mengidentifikasi sumber laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin di dalam rumah sakit.
 - 2) Melakukan telaah atas laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi.
- b. Membuat keputusan. Pengambilan keputusan pelanggaran etik profesi dilakukan dengan melibatkan panitia Adhoc.
- c. Melakukan tindak lanjut keputusan berupa :
 - 1) Pelanggaran etik direkomendasikan kepada organisasi profesi keperawatan dan kebidanan di rumah sakit melalui Ketua Komite.
 - 2) Pelanggaran disiplin profesi diteruskan kepada kepala bidang keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur rumah sakit.
 - 3) Rekomendasi pencabutan kewenangan klinis diusulkan kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
- d. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan, meliputi:
 - 1) Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik keperawatan dan kebidanan sehari – hari.
 - 2) Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/ topik dan metode serta evaluasi.
 - 3) Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, “coaching”, simposium, “bedside teaching”, diskusi refleksi kasus dan lain – lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia.
- e. Menyusun laporan kegiatan sub komite untuk disampaikan kepada Ketua Komite Keperawatan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

1. Prosedur monitoring kredensial

- a. Persiapan
 - 1) Siapkan daftar seluruh perawat aktif dari bagian SDM.
 - 2) Siapkan database kredensial dan dokumen pendukung (STR, SIP, clinical privilege).
 - 3) Gunakan formulir monitoring kredensial yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan monitoring
 - 1) Periksa masa berlaku STR setiap perawat.
 - 2) Periksa masa berlaku SIP sesuai unit kerja.
 - 3) Periksa masa berlaku clinical privilege dan hasil rekredensial.
 - 4) Identifikasi perawat yang mendekati masa kedaluwarsa (≤ 3 bulan).
 - 5) Catat temuan pada formulir monitoring
- c. Tindak lanjut
 - 1) Sampaikan pemberitahuan tertulis kepada perawat yang masa berlaku dokumennya akan habis.
 - 2) Koordinasikan dengan Bidang Keperawatan dan SDM terkait perpanjangan.
 - 3) Jadwalkan rekredensial sesuai ketentuan.
 - 4) Rekomendasikan penangguhan kewenangan klinis apabila dokumen tidak aktif
- d. Dokumentasi
 - 1) Arsipkan hasil monitoring dalam berkas Komite Keperawatan.
 - 2) Simpan dokumen dalam lemari arsip terkunci atau sistem elektronik yang aman
- e. Frekuensi monitoring
 - 1) Dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap 3 bulan.
 - 2) Dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat temuan khusus

2. Prosedur monitoring mutu profesi

- a. Persiapan
 - 1) Tetapkan indikator mutu profesi keperawatan yang akan dimonitor.
 - 2) Siapkan instrumen audit/lembar monitoring.
 - 3) Koordinasikan jadwal monitoring dengan kepala ruangan/unit terkait
- b. Pelaksanaan monitoring
 - 1) Lakukan audit rekam medis/asuhan keperawatan secara sampling.
 - 2) Observasi langsung praktik keperawatan di unit pelayanan.
 - 3) Telaah laporan insiden keselamatan pasien terkait praktik keperawatan.
 - 4) Verifikasi kesesuaian praktik dengan clinical privilege yang dimiliki.
 - 5) Catat seluruh temuan dalam formulir monitoring mutu profesi
- c. Analisis dan evaluasi
 - 1) Rekapitulasi hasil monitoring.
 - 2) Analisis tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
 - 3) Identifikasi akar masalah apabila ditemukan ketidaksesuaian.

-
- 4) Susun rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut (RTL).
 - d. Tindak lanjut
 - 1) Sampaikan hasil monitoring kepada kepala ruangan/unit terkait.
 - 2) Rekomendasikan pembinaan atau pelatihan jika diperlukan.
 - 3) Rekomendasikan peninjauan ulang kewenangan klinis bila terdapat pelanggaran.
 - 4) Lakukan monitoring ulang terhadap tindak lanjut perbaikan
 - e. Frekuensi monitoring
 - 1) Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 3 bulan.
 - 2) Dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terjadi insiden atau temuan khusus
3. Monitoring etik dan disiplin
- a. Penerimaan laporan
 - 1) Terima laporan dugaan pelanggaran secara tertulis atau melalui sistem pengaduan resmi.
 - 2) Catat laporan dalam buku register kasus etik dan disiplin.
 - 3) Jaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor
 - b. Verifikasi awal
 - 1) Lakukan telaah awal terhadap kelengkapan laporan.
 - 2) Kumpulkan data pendukung (rekam medis, kronologi, saksi).
 - 3) Tentukan apakah kasus termasuk ranah etik, disiplin, atau keduanya
 - c. Pelaksanaan monitoring dan investigasi
 - 1) Bentuk tim kecil atau subkomite etik/disiplin.
 - 2) Lakukan klarifikasi kepada perawat yang bersangkutan.
 - 3) Lakukan wawancara kepada saksi atau pihak terkait.
 - 4) Analisis kesesuaian tindakan dengan kode etik dan regulasi yang berlaku.
 - 5) Dokumentasikan seluruh proses dalam berita acara pemeriksaan
 - d. Rapat pembahasan
 - 1) Laksanakan rapat Komite Keperawatan untuk membahas hasil investigasi.
 - 2) Tentukan rekomendasi tindak lanjut secara musyawarah.
 - 3) Buat berita acara hasil rapat.
 - e. Rekomendasi dan tindak lanjut
 - 1) Sampaikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit.
 - 2) Rekomendasikan pembinaan, pelatihan ulang, supervisi, atau tindakan disiplin sesuai tingkat pelanggaran.
 - 3) Rekomendasikan pembatasan atau pencabutan sementara kewenangan klinis apabila diperlukan
 - f. Monitoring tindak lanjut
 - 1) Pantau pelaksanaan rekomendasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Evaluasi efektivitas pembinaan atau sanksi.
 - 3) Tutup kasus apabila seluruh tindak lanjut telah dilaksanakan

4.2 Evaluasi

1. Perencanaan
 - a. Tetapkan jadwal evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - b. Tentukan indikator kinerja Komite Keperawatan.
 - c. Siapkan instrumen dan format evaluasi.
 - d. Koordinasikan jadwal evaluasi dengan anggota komite
2. Pengumpulan data
 - a. Kumpulkan data hasil monitoring kredensial.

-
- b. Kumpulkan data hasil monitoring mutu profesi.
 - c. Kumpulkan data penanganan kasus etik dan disiplin.
 - d. Kumpulkan data capaian program kerja tahunan
 3. Analisis dan penilaian
 - a. Rekapitulasi seluruh data yang telah dikumpulkan.
 - b. Hitung capaian masing-masing indikator kinerja.
 - c. Bandingkan hasil capaian dengan target yang ditetapkan.
 - d. Identifikasi penyebab ketidaktercapaian target.
 - e. Rumuskan rekomendasi perbaikan
 4. Rapat evaluasi
 - a. Laksanakan rapat evaluasi Komite Keperawatan.
 - b. Paparkan hasil analisis secara objektif.
 - c. Bahas temuan dan hambatan secara menyeluruh.
 - d. Tetapkan rencana tindak lanjut (RTL).
 - e. Buat dan tandatangani berita acara rapat

4.3 Pelaporan

1. Penyusunan laporan
 - a. Susun laporan evaluasi secara tertulis dan sistematis.
 - b. Cantumkan ringkasan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - c. Cantumkan capaian indikator kinerja.
 - d. Uraikan permasalahan dan hasil analisis.
 - e. Cantumkan rencana tindak lanjut yang telah disepakati
2. Penyampaian laporan
 - a. Sampaikan laporan evaluasi kepada Direktur Rumah Sakit secara triwulan dan tahunan.
 - b. Sampaikan tembusan laporan kepada Bidang Keperawatan dan Komite Mutu bila diperlukan.
 - c. Presentasikan laporan dalam forum manajemen apabila diminta
3. Dokumentasi
 - a. Arsipkan laporan dalam dokumen Komite Keperawatan.
 - b. Simpan dokumen dalam lemari arsip terkunci atau sistem elektronik yang aman.
 - c. Jaga kerahasiaan data sesuai kebijakan rumah sakit

BAB V

PENUTUP

Pedoman Kerja Komite Keperawatan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Komite Keperawatan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan, keselamatan pasien, serta pengembangan profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh anggota Komite Keperawatan dapat melaksanakan kegiatan kredensial, pengembangan mutu profesi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi secara terarah, konsisten, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, serta standar akreditasi yang berlaku.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dilakukan evaluasi serta penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, regulasi, dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kerja sama, dan dukungan dari seluruh unsur manajemen rumah sakit, tenaga keperawatan, serta pihak terkait lainnya agar pelaksanaan tugas Komite Keperawatan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Demikian Pedoman Kerja Komite Keperawatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang efektif dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang profesional, bermutu, beretika, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pasuruan, 1 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

Ketua Komite Keperawatan



Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep